医療AIの倫理

医療AIの倫理的懸念と実装戦略

研修医・専攻医向けスライド（15分）

参考文献

2026-03-29 ・ AI（Claude）作成・主な出典は原典で確認

問いの投げかけ

「この患者、敗血症リスク”高”です」— AIがそう言ったら？

シナリオ:

深夜の救急外来。38.5度の発熱と頻脈で搬送された72歳女性。

AIシステムが「敗血症リスク: 高（92%）」とアラート（数字は議論のための架空の設定で、実在の製品の性能ではない）。

しかし、あなたの臨床的印象は「単純性尿路感染症」。

問い: あなたはAIの判断をどう扱いますか？

今日のゴール

この15分で手に入れるもの

1. **説明できる:** 医療AIの倫理的懸念を6つのカテゴリで構造的に整理できる
2. **分析できる:** 臨床シナリオにおけるAI判断のバイアス源を特定できる
3. **計画できる:** AIの推奨と自身の臨床判断を統合するプロセスを言語化できる

あなたがすでに知っていること

臨床倫理の4原則を思い出そう

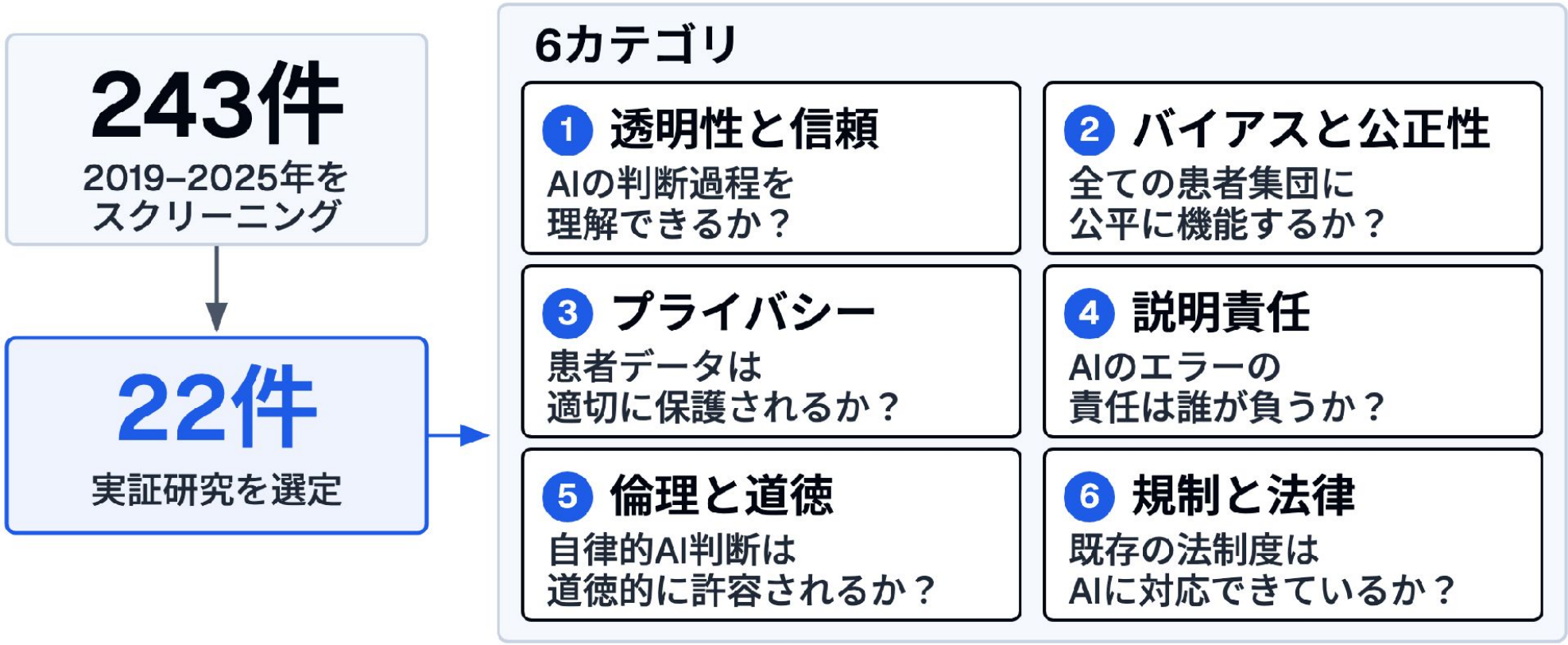
バイオエシックスの4原則(Beauchamp & Childress):

原則	内容	AIとの接点は？
自律尊重(Autonomy)	患者の意思決定を尊重	AIが推奨→患者の選択はどうなる？
善行(Beneficence)	患者に最善を尽くす	AIの精度が人間を超えたら？
無危害(Non-maleficence)	害を与えない	AIの誤判断で害が生じたら？
正義(Justice)	公平・公正	AIが特定集団で精度低下したら？

ポイント: この4原則をAI文脈に「再解釈」する必要がある — それが今日のテーマ。

6つの倫理的懸念カテゴリ

システマティックレビューが体系化した全体像



出典: Wubineh et al., BMC Medical Ethics 2026

カテゴリ深掘り（1）透明性と信頼

ブラックボックス問題

問題の核心: 深層学習モデルは「なぜその判断をしたか」を説明できない

- **ブラックボックス:** 入力→出力は分かるが、中間の推論過程が不透明
- **XAI（Explainable AI / 説明可能AI）:** 判断根拠を可視化する技術（例: SHAP、LIME）
  - しかし、XAIの「説明」は人間の「理解」と同義ではない
- **臨床的含意:** 「AIがそう言っているから」では患者への説明責任を果たせない

批判的吟味の視点: あなたが使うAIツールは、判断の根拠を示してくれるか？

カテゴリ深掘り（2）バイアスと公正性

3層のバイアス構造

バイアスは3つの層で発生する:

層	内容	具体例
データバイアス	訓練データの偏り	白人肌データ中心→有色人種で皮膚がんAI精度低下
アルゴリズムバイアス	特徴量選択の暗黙の仮定	人種を代理変数として使用
システムバイアス	医療制度の歴史的不平等の再生産	受診率が低い集団のデータが少ない→さらにケア格差拡大

カテゴリ深掘り（2）バイアスと公正性(続き)

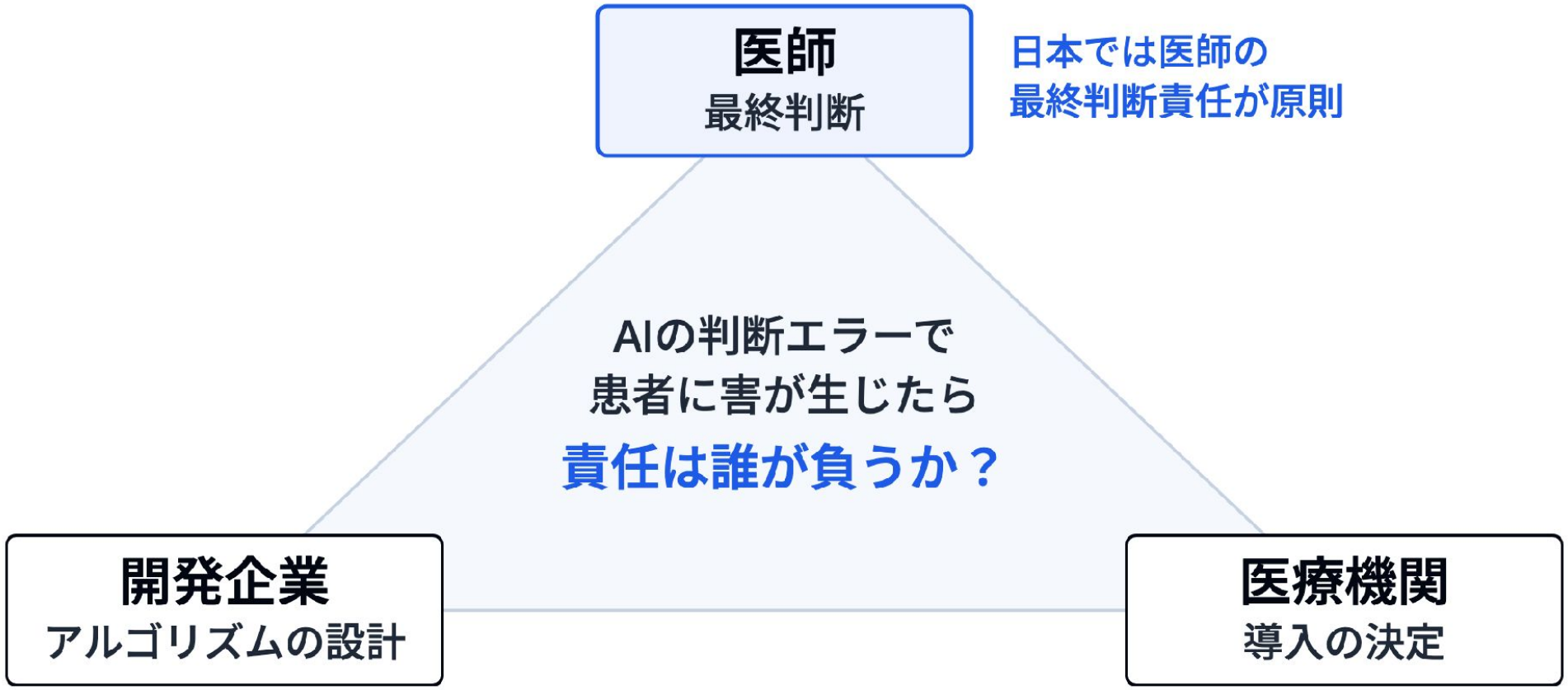
Fairness Impossibility Theorem(不可能性定理):

公正性の複数指標(Demographic Parity, Equalized Odds, Predictive Parity)を**同時に全て満たすことは数学的に不可能。**

どの指標を優先するかは**倫理的判断**であり、技術的判断ではない。

カテゴリ深掘り（3）説明責任と規制

責任の三角形



説明責任と規制 — 現状と課題

- 現状: 日本では医師の最終判断責任が原則
- 課題: AIが「推奨」し医師が「承認」するだけの運用になった場合は？
- EU AI法: 医療機器に組み込まれる高リスクAIに技術文書・人間の監視などを義務化（2026年7月の改正で適用は2028年8月に延期）

ペアディスカッション

冒頭のシナリオに戻ろう

シナリオの再提示:

AIが「敗血症リスク: 高（92%）」→ あなたの印象は「単純性UTI」

ペアで3分間ディスカッション（6つのカテゴリをフレームワークとして使う）:

1. このAIシステムの**透明性**はどうか？（92%の根拠は見えるか？）
2. この患者に特有の**バイアス**リスクはないか？（年齢、性別、併存疾患）
3. AIの判断を採用/不採用にした場合、**説明責任**はどこにあるか？
4. 「AIを**使わない**ことの倫理的責任」はあるか？

共有と振り返り

全体共有 + ファシリテーターコメント

共有のポイント:

- 各ペアから1つずつ意見を共有（30秒×数ペア）
- ファシリテーターが6カテゴリへのマッピングを補足

重要なメッセージ:

> *AIは「第二の意見」であり、「最終判断」ではない。*
>
> *しかし、AIの指摘を無視する場合にも、その根拠を言語化する責任がある。*

レビューの4つの提言

実装戦略として何が推奨されているか

Wubineh et al.の提言:

1. **倫理原則・基準の遵守** — バイオエシックス4原則をAI文脈に再解釈
2. **透明性の確保** — XAI手法の実装、意思決定プロセスの可視化
3. **継続的な監視・監査** — デプロイ後のバイアスモニタリング、パフォーマンスドリフト検出
4. **多職種ステークホルダー参加のガバナンス** — 開発者・臨床医・患者・倫理学者・規制当局の協働

振り返りの問い: あなたの病院でAI導入を検討するとき、この4つのうちどれが最も不足しているか？

まとめ

持ち帰りの問い

明日からの臨床で

3つの持ち帰りの問い:

1. 今日使ったAIツール（UpToDate、画像診断AI等）の判断根拠を、患者に説明できるか？
2. そのツールの訓練データに、目の前の患者と同じ集団は含まれているか？
3. AIの推奨と自分の判断が食い違ったとき、どちらを選ぶかの「思考プロセス」を言語化できるか？

参考文献

Wubineh BZ, Deriba FG, Gemeda FW. Ethical concerns and strategies for implementing artificial intelligence in healthcare: a review of empirical studies. BMC Medical Ethics. 2026;27:53. https://doi.org/10.1186/s12910-026-01404-8
Harvard Gazette. AI is speeding into healthcare — who should regulate it? 2026. https://news.harvard.edu/gazette/story/2026/01/ai-is-speeding-into-healthcare-who-should-regulate-it/
WHO. Ethics and governance of artificial intelligence for health: guidance on large multi-modal models. 2024. https://www.who.int/publications/i/item/9789240084759
Regulation (EU) 2026/1744 (Digital Omnibus on AI), OJ L, 24.7.2026. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2026/1744/oj
Regulation (EU) 2024/1689 (Artificial Intelligence Act). https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj
JYI. Bias in Medical AI: Algorithmic Fairness and Ethics Challenges. 2026. https://www.jyi.org/2026-january-1/2026/1/8/bias-in-medical-ai-algorithmic-fairness-and-ethics-challenges